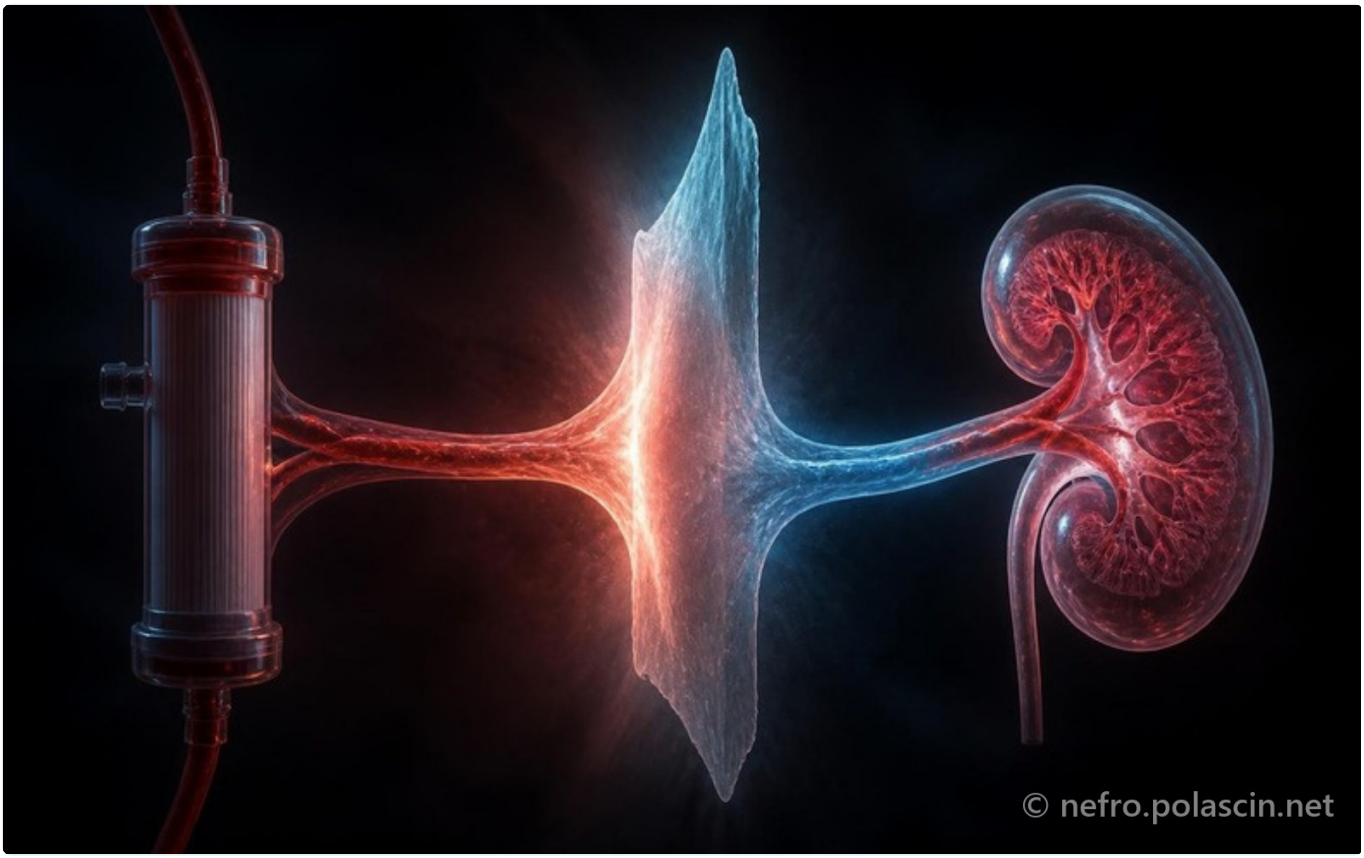
Checklist do praxe (1 strana A4): Anémia pri CKD (HD aj non-HD)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.06.2026



Ilustračná scéna. Jedna strana, dve situácie – hemodialyzovaný a nedialyzovaný pacient potrebujú odlišné kroky.

Tento checklist je určený na rýchle použitie v ambulancii aj na dialýze. Pomáha potvrdiť anémiu, vyhodnotiť železo, rozhodnúť o liečbe podľa skupiny pacienta a jasne zapísať, prečo bol zvolený konkrétny postup.

1) Potvrdenie anémie a rýchle zhodnotenie

- ☐ **Hb** a trend v čase (dátum, predchádzajúce hodnoty)
- ☐ **CBC** s MCV a RDW + **retikulocyty**
- ☐ Symptómy a tolerancia záťaže: únava, dyspnoe, iné
- ☐ Rýchle zhodnotenie príčiny: zápal/infekcia, krvácanie, výživa (klinicky)
- ☐ Ak obraz nezodpovedá anémii pri CKD, doplniť plán ďalšej diagnostiky

2) Železo: laboratórny profil

- ☐ **Ferritín** (ng/ml): _____
- ☐ **TSAT** (%): _____
- ☐ Interpretácia v kontexte zápalu, ak je relevantný

3) Voľba liečby železom podľa skupiny

A) CKD G5HD (hemodialýza)

- ☐ Pri **ferritíne ≤ 500 ng/ml** a **TSAT ≤ 30 %** začať **IV železo**
- ☐ Bezpečnostná hranica: zadržať rutinné železo, ak **ferritín > 700 ng/ml** alebo **TSAT ≥ 40 %**

- ☐ Typ IV železa a dávkovací plán: _____

B) CKD bez HD / PD

- ☐ Zvoliť perorálne vs IV železo podľa ferritínu, TSAT, tolerancie, dostupnosti a potreby rýchlej korekcie
- ☐ Pri začatí IV železa zvážiť riziká, najmä pri FCM

4) Špeciálne: FCM a fosfát

- ☐ Použitý prípravok: FCM / iné: _____
- ☐ Ak FCM: plán monitorovania **fosfátu**, hlavne u rizikových pacientov alebo pri nových symptómoch
- ☐ Príznaky po podaní: slabosť, bolesti kostí, iné _____
- ☐ Fosfát: dátum/kedy kontrolovať _____

5) Rozhodnutie o ESA alebo HIF-PHI

- ☐ Pred nasadením sú riešené korektibilné príčiny, najmä deficit železa
- ☐ Zdieľané rozhodovanie s pacientom: benefit vs riziká vrátane transfúzie
- ☐ Typ terapie: ESA / HIF-PHI / zatiaľ nie
- ☐ Pri CKD G5D zvážiť ESA typicky pri **Hb ~ ≤ 9,0 až 10,0 g/dl** podľa symptómov a trendu
- ☐ Pri udržiavaní držať **Hb pod hornou hranicou ~ 11,5 g/dl**

6) Monitoring a kontrolné intervaly

- ☐ Kontrola **Hb, ferritín, TSAT**
- ☐ Non-HD a CKD G5PD: **každé 3 mesiace**
- ☐ CKD G5HD: **každých 1 až 3 mesiace**
- ☐ Prehodnotenie pri zmene klinického stavu: infekcia, hospitalizácia, krvácanie, rýchly pokles Hb
- ☐ Návrh ďalšej kontroly: [DD.MM.RRRR]

7) Dokumentácia pre audit

- ☐ Zapísať aktuálne hodnoty (Hb, ferritín, TSAT ± retikulocyty), interpretáciu a dôvod zvoleného postupu
- ☐ Zapísať hranice a odôvodnenie pri začatí alebo zadržaní železa
- ☐ Zapísať cieľ Hb a plán monitorovania
- ☐ Ak sa zvolil FCM, zapísať dôvod a plán sledovania fosfátu pri opakovaných dávkach

---

Zdroj: *KDIGO 2026 a KDOQI US Commentary on the Management of Anemia in CKD.* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=anemia-ckd-checklist-a4-hd-nonhd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.